



AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM
PREPARACIÓN MÉDICA DE EXCELENCIA • CHILE

TOMO 11 • 1ª EDICIÓN 2026

MÓDULO 2

CIRUGÍA GENERAL

90 Preguntas de Práctica

Abdomen Agudo & Anestesia

MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Cirugía General · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

TOMO 11 · PARTE A: POR BLOQUES

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO					
4.01.1.002	Divertículos esofágicos	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q1	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.005	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q8	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.008	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q9	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.014	Pólipos de colon y recto	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q2	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.015	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q10	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.019	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q11	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.025	Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q7	Tomo 13 · 13.4 (Pág. 15)
4.01.1.028	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q12	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.030	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q13	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.031	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q14	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.033	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q15	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.035	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q16	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.037	Hidatidosis pulmonar	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q3	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.039	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q17	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.040	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q18	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.044	Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q4	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.045	Enfermedad renovascular	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg:	—	Q5	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
Derivar					
4.01.1.049	Trombosis venosa profunda y tromboflebitis	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q6	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
BLOQUE 2: ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO					
4.01.1.001	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q24	Tomo 12 · 12.1 (Pág. 5)
4.01.1.003	Divertículo de Meckel	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q19	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.006	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q22	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.007	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q32	Tomo 13 · 13.1 (Pág. 5)
4.01.1.009	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q33	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.011	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q25	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.016	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q26	Tomo 11 · 11.7 (Pág. 30)
4.01.1.017	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q27	Tomo 11 · 11.7 (Pág. 30)
4.01.1.018	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q34	Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32)
4.01.1.020	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q28	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.021	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q23	Tomo 11 · 11.6 (Pág. 26)
4.01.1.022	Hidatidosis hepática	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q20	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.023	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q29	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.024	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q35	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.032	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q36	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.034	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q30	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	Internas/Externas & Abscesos/Fístulas				
4.01.1.036	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q31	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.038	Nódulo pulmonar solitario	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q21	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
BLOQUE 3: POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)					
4.01.1.004	Acalasia	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q37	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.026	Ictericia obstructiva	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q38	Tomo 11 · C.13 (Pág. 30)
4.01.1.041	Síndromes mediastínicos	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q39	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.046	Insuficiencia cerebro vascular	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q40	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.050	Úlceras de las piernas (venosas, varicosas, hipert. y específicas)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q41	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.051	Pie diabético	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q42	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.053	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q52	Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32)
4.01.1.054	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q53	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.055	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q51	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.056	Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q54	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.058	Condilomas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q43	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.059	Onicocriptosis	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q44	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.060	Obesidad mórbida	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q45	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.002	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q46	Tomo 13 · 13.5 (Pág. 20)
4.01.2.003	Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q50	Tomo 11 · 11.5 (Pág. 21)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.2.005	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q49	Tomo 11 · 11.4 (Pág. 17)
4.01.2.006	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q47	Tomo 11 · 11.1 (Pág. 5)
4.01.2.007	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q48	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

BLOQUE 4: POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)

4.01.1.012	Megacolon	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q55	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.027	Litiasis biliar	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q56	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.042	Mesotelioma pleural	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q57	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.047	Insuficiencia arterial crónica	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q58	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.052	Escaras	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q59	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.001	Esofagitis cáustica	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q60	Tomo 13 · 13.2 (Pág. 9)
4.01.2.008	Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q71	Tomo 11 · 11.3 (Pág. 13)
4.01.2.009	Prolapso rectal	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q61	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.010	Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q68	Tomo 11 · 11.11 (Pág. 45)
4.01.2.011	Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q70	Tomo 11 · 11.2 (Pág. 9)
4.01.2.012	Colangitis	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q62	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.013	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q65	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.015	Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q72	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.016	Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q66	Tomo 11 · 11.10 (Pág. 41)
4.01.2.017	Supuración pulmonar	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q63	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.018	Hemoptisis masiva	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q64	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.2.020	Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q69	Tomo 12 · 12.6 (Pág. 24)
4.01.2.021	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q67	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
BLOQUE 5: PREOPERATORIO, ANESTESIA & COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS					
4.01.1.013	Enfermedad diverticular no complicada	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q73	Tomo 07 · 1.4 (Pág. 15)
4.01.1.029	Pancreatitis crónica	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q74	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.043	Síndrome de ocupación pleural	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q75	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.048	Várices. Insuficiencia venosa crónica	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q76	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.057	Cicatrices viciosas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q77	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.004	Hemorragia digestiva alta	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q78	Tomo 14 · 14.15 (Pág. 56)
4.01.2.014	Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q87	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.019	Perforación esofágica - Mediastinitis	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q79	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.022	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q89	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.023	Traumatismos vasculares	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q80	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.024	Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q86	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.025	Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q88	Tomo 11 · C.3 (Pág. 10)
4.01.2.026	Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q84	Tomo 11 · 11.13 (Pág. 53)
4.01.2.027	Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q90	Tomo 11 · 11.9 (Pág. 37)
4.01.2.028	Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q85	Tomo 11 · 11.15 (Pág. 62)
4.01.2.029	Septicemia	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q81	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.030	Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q83	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.2.031	Shock	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q82	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.1.001	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q24	Tomo 12 · 12.1 (Pág. 5)
4.01.1.002	Divertículos esofágicos	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q1	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.003	Divertículo de Meckel	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q19	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.004	Acalasia	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q37	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.005	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q8	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.006	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q22	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.007	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q32	Tomo 13 · 13.1 (Pág. 5)
4.01.1.008	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q9	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.009	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q33	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.011	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q25	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.012	Megacolon	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q55	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.013	Enfermedad diverticular no complicada	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q73	Tomo 07 · 1.4 (Pág. 15)
4.01.1.014	Pólipos de colon y recto	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q2	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.015	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q10	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.016	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q26	Tomo 11 · 11.7 (Pág. 30)
4.01.1.017	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q27	Tomo 11 · 11.7 (Pág. 30)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.1.018	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q34	Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32)
4.01.1.019	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bidas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q11	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.020	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q28	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.021	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Completo	GES	Q23	Tomo 11 · 11.6 (Pág. 26)
4.01.1.022	Hidatidosis hepática	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q20	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.023	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q29	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.024	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q35	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.025	Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q7	Tomo 13 · 13.4 (Pág. 15)
4.01.1.026	Ictericia obstructiva	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q38	Tomo 11 · C.13 (Pág. 30)
4.01.1.027	Litiasis biliar	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q56	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.028	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bidas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q12	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.029	Pancreatitis crónica	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q74	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.030	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bidas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q13	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.031	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bidas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q14	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.032	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q36	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.033	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bidas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q15	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.034	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q30	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.035	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bidas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q16	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.036	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg:	GES	Q31	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Completo			
4.01.1.037	Hidatidosis pulmonar	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q3	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.038	Nódulo pulmonar solitario	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q21	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.039	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q17	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.040	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q18	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.041	Síndromes mediastínicos	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q39	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.042	Mesotelioma pleural	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q57	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.043	Síndrome de ocupación pleural	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q75	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.044	Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q4	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.045	Enfermedad renovascular	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q5	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.046	Insuficiencia cerebro vascular	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q40	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.047	Insuficiencia arterial crónica	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q58	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.048	Várices. Insuficiencia venosa crónica	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q76	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.049	Trombosis venosa profunda y tromboflebitis	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q6	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.050	Úlceras de las piernas (venosas, varicosas, hipert. y específicas)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q41	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.051	Pie diabético	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q42	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.052	Escaras	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Completo	—	Q59	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.053	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q52	Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32)
4.01.1.054	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q53	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.1.055	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	GES	Q51	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.056	Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q54	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.057	Cicatrices viciosas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q77	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.058	Condilomas	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q43	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.059	Onicocriptosis	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q44	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.060	Obesidad mórbida	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q45	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.001	Esofagitis cáustica	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q60	Tomo 13 · 13.2 (Pág. 9)
4.01.2.002	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q46	Tomo 13 · 13.5 (Pág. 20)
4.01.2.003	Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q50	Tomo 11 · 11.5 (Pág. 21)
4.01.2.004	Hemorragia digestiva alta	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q78	Tomo 14 · 14.15 (Pág. 56)
4.01.2.005	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q49	Tomo 11 · 11.4 (Pág. 17)
4.01.2.006	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q47	Tomo 11 · 11.1 (Pág. 5)
4.01.2.007	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q48	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.008	Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q71	Tomo 11 · 11.3 (Pág. 13)
4.01.2.009	Prolapso rectal	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q61	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.010	Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q68	Tomo 11 · 11.11 (Pág. 45)
4.01.2.011	Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q70	Tomo 11 · 11.2 (Pág. 9)
4.01.2.012	Colangitis	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q62	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.013	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q65	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.2.014	Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q87	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.015	Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q72	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.016	Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q66	Tomo 11 · 11.10 (Pág. 41)
4.01.2.017	Supuración pulmonar	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q63	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.018	Hemoptisis masiva	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q64	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.019	Perforación esofágica - Mediastinitis	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q79	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.020	Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q69	Tomo 12 · 12.6 (Pág. 24)
4.01.2.021	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q67	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.022	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q89	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.023	Traumatismos vasculares	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q80	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.024	Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q86	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.025	Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Completo	—	Q88	Tomo 11 · C.3 (Pág. 10)
4.01.2.026	Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q84	Tomo 11 · 11.13 (Pág. 53)
4.01.2.027	Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q90	Tomo 11 · 11.9 (Pág. 37)
4.01.2.028	Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	GES	Q85	Tomo 11 · 11.15 (Pág. 62)
4.01.2.029	Septicemia	Dx: Sospecha Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q81	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.030	Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia	Dx: Específico Tx: Completo · Seg: Derivar	—	Q83	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.031	Shock	Dx: Específico Tx: Inicial · Seg: Derivar	—	Q82	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO**PREGUNTA 1**

4.01.1.002

1. [ATENCIÓN PRIMARIA: Divertículos esofágicos · 4.01.1.002] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Divertículos esofágicos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 2

4.01.1.014

2. [ATENCIÓN PRIMARIA: Pólipos de colon y recto · 4.01.1.014] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Pólipos de colon y recto. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 3

4.01.1.037

3. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hidatidosis pulmonar · 4.01.1.037] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hidatidosis pulmonar. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 4

4.01.1.044

4. [ATENCIÓN PRIMARIA: Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea · 4.01.1.044] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

5. [ATENCIÓN PRIMARIA: Enfermedad renovascular · 4.01.1.045] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Enfermedad renovascular. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroideos sin controles.

6. Una paciente de 25 años, es operada de apendicitis aguda hace 24 horas, actualmente se encuentra muy decaída y con dificultad respiratoria. Al examen físico destaca pálida, frecuencia cardíaca de 110 por minuto y con presión arterial de 90/60. El diagnóstico más probable es:

- A) Atelectasia
- B) Reacción adversa a medicamentos
- C) Tromboembolismo pulmonar
- D) Infección de herida operatoria
- E) Hemoperitoneo

7. [ATENCIÓN PRIMARIA: Colecistitis crónica · 4.01.1.025] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Colecistitis crónica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroideos sin controles.

8. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer del esófago · 4.01.1.005] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer del esófago. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroideos sin controles.

9. Un paciente de con antecedente de cáncer gástrico avanzado, con metástasis hepáticas múltiples y adenopatías perigástricas, consulta por cuadro de vómitos postprandiales intensos, que han ido en aumento y actualmente dificultan mucho la alimentación. Al examen físico está muy enflaquecido, con ausencia de grasa y con edema de extremidades inferiores. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Instalar sonda nasogástrica
- B) Indicar nutrición parenteral total
- C) Realizar radioterapia de urgencia
- D) Realizar gastrectomía paliativa
- E) Realizar derivación gastrointestinal

10. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer colorectal · 4.01.1.015] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer colorectal. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroideos sin controles.

11. Un paciente de 45 años, diagnosticado de VIH, presenta sangrado rectal ocasional. Al examen físico, se observa lesión solevantada en los márgenes anales, de 4 cm, que se introduce en el recto, sobrepasando la línea pectínea, con una con una ulceración central, con escaso sangrado. El diagnóstico más probable es:

- A) Hemorroide externa trombosado
- B) Condiloma acuminado
- C) Sífilis
- D) Cáncer epidermoide
- E) Enfermedad de Cröhn

12. Una paciente de 60 años, se realiza una colecistectomía laparoscópica electiva, por una coleditis. La biopsia es informada como presencia adenocarcinoma invasor en el fondo de la vesícula, subseroso. Se solicita un TAC de abdomen y pelvis con contraste, que no visualiza metástasis. ¿Cuál es la conducta?

- A) Quimioterapia
- B) Radioterapia
- C) Cuidados paliativo
- D) Control con TAC cada 3 meses
- E) Colecistectomía radical

13. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer de páncreas y otros tumores preampulares · 4.01.1.030] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer de páncreas y otros tumores preampulares. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroideos sin controles.

14. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer de páncreas · 4.01.1.031] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer de páncreas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroideos sin controles.

15. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer del tiroides · 4.01.1.033] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer del tiroides. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroideos sin controles.

16. Una paciente de 60 años presenta aumento de volumen en la axila derecha, de 4 cm de diámetro, indolora, de consistencia dura y adherida a planos profundos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Hidrosadenitis
- B) Cáncer de mama
- C) Cáncer de pulmón
- D) Lipoma
- E) Tuberculosis ganglionar

17. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cáncer pulmonar · 4.01.1.039] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cáncer pulmonar. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

18. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hernias diafragmáticas traumáticas y congénitas · 4.01.1.040] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hernias diafragmáticas traumáticas y congénitas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

BLOQUE 2 ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO

19. [ATENCIÓN PRIMARIA: Divertículo de Meckel · 4.01.1.003] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Divertículo de Meckel. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

20. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hidatidosis hepática · 4.01.1.022] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hidatidosis hepática. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

21. [ATENCIÓN PRIMARIA: Nódulo pulmonar solitario · 4.01.1.038] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Nódulo pulmonar solitario. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

22. [ATENCIÓN PRIMARIA: Hernia hiatal · 4.01.1.006] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hernia hiatal. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

23. Una paciente de 60 años consulta por aumento de volumen en la cara anterior del muslo, que en ocasiones es dolorosa y se asocia a náuseas y dolor abdominal. Al examen físico se aprecia dicho aumento de volumen, por debajo del ligamento inguinal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Linfoma
- B) Hernia inguinal
- C) Adenopatía metastásica
- D) Hernia femoral
- E) Sarcoma de partes blandas

24. [ATENCIÓN PRIMARIA: Patología glándulas salivales · 4.01.1.001] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Patología glándulas salivales. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

25. [ATENCIÓN PRIMARIA: Fístulas del intestino delgado · 4.01.1.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Fístulas del intestino delgado. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

26. Paciente de 52 años con hemorroides externas trombosadas desde hace 6 horas, violáceas, protruidas, irreducibles y muy dolorosas. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

- A) Hemorroidectomía de urgencia
- B) Trombectomía hemorroidal bajo anestesia local
- C) Ligadura con banda elástica
- D) Manejo médico conservador con analgesia y baños de asiento
- E) Escleroterapia

27. Un hombre de 60 años presenta aumento de volumen doloroso en la zona sacra baja. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de 4 cm de diámetro, dolorosa a la palpación, fluctuante, con signos inflamatorios. El tratamiento más adecuado es:

- A) Curación plana
- B) Drenaje quirúrgico
- C) Antibióticos orales
- D) Punción y drenaje
- E) Analgésicos

28. Un paciente de 54 años consulta por dolor anal, que se presenta al defecar, persistiendo por algunos minutos luego de la defecación. En algunas ocasiones además ha presentado sangre en las deposiciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Hemorroide externo trombosado
- B) Cáncer de recto
- C) Fisura anal
- D) Fístula anal
- E) Absceso perianal

29. [ATENCIÓN PRIMARIA: Quistes y abscesos hepáticos · 4.01.1.023] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Quistes y abscesos hepáticos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

30. [ATENCIÓN PRIMARIA: Patología benigna del tiroides · 4.01.1.034] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Patología benigna del tiroides. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

31. Un paciente de 35 años presenta un nódulo mamario, desde hace 8 meses. Su ecografía mamaria muestra un tumor de aspecto sólido, bordes bien delimitados, sin refuerzo posterior y con un índice ultrasonográfico Birsads 3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Mastopatía fibroquística
- B) Papiloma ductal
- C) Fibroadenoma
- D) Tumor phylloides
- E) Carcinoma ductal

32. [ATENCIÓN PRIMARIA: Tumores gástricos benignos · 4.01.1.007] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tumores gástricos benignos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

33. [ATENCIÓN PRIMARIA: Tumores del intestino delgado · 4.01.1.009] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tumores del intestino delgado. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

34. Una paciente de 20 años presenta aumento de volumen eritematoso y doloroso, en la zona interglútea, ubicado a dos centímetros de la línea media, sobre el coxis. Al examen físico, se observa aumento de volumen de 5 cm, doloroso, con presencia de dos orificios negros en la piel, cerca de la lesión. El diagnóstico más probable es:

- A) Linfoma
- B) Sarcoma
- C) Quiste pilonidal
- D) Absceso anorrectal
- E) Lipoma

35. [ATENCIÓN PRIMARIA: Tumores hepáticos · 4.01.1.024] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tumores hepáticos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

36. Un paciente de 25 años de edad, sin patologías previas, presenta desde hace 4 años aumento de volumen cervical lateral, que ha ido creciendo. Al examen se constata una masa palpable, de 3 cm, en la zona lateral del cuello, de ubicación submandibular. Se solicita una ecografía cervical, que muestra un nódulo hipocogénico, de bordes bien delimitados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Nódulo tiroideo
- B) Quiste branquial
- C) Quiste tirogloso
- D) Linfadenopatía tuberculosa
- E) Tumor de glándula salival secundaria

37. [ATENCIÓN PRIMARIA: Acalasia · 4.01.1.004] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Acalasia. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

38. Paciente que empieza con ictericia 7 días post colecistectomía:

- A) Litiasis en vía biliar común
- B) Lesión vía biliar iatrogénica
- C) Ninguna de las anteriores es correcta
- D) Todas las anteriores son correctas
- E) No se dispone de información suficiente

39. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndromes mediastínicos · 4.01.1.041] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndromes mediastínicos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

40. [ATENCIÓN PRIMARIA: Insuficiencia cerebro vascular · 4.01.1.046] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Insuficiencia cerebro vascular. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

41. Un paciente de 58 años, con antecedente de várices en ambas piernas, de gran tamaño, consulta porque hace dos semanas sufrió un pequeño trauma en su extremidad inferior izquierda, evolucionando con una lesión ulcerada que ha aumentado de tamaño, hasta alcanzar 1,5 cm y que se ubica a 2 cm del maléolo interno. Al examen físico, se aprecia oscurecimiento de la piel circundante, más la presencia de las várices descritas. ¿Cuál es la etiología más probable de su lesión?

- A) Infecciosa
- B) Isquémica
- C) Venosa
- D) Neuropática
- E) Por presión

42. Un paciente de 65 años, diabético en tratamiento con esquema intensificado de insulina, presenta desde hace unas semanas úlcera en zona plantar derecha, asociado a secreción purulenta. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones y afebril, se aprecia úlcera bajo la articulación metatarsofalángica del primer orjeo derecho, con compromiso de piel, tejido subcutáneo y tendones, sin signos de compromiso óseo ni articular. La conducta más adecuada en este caso es:

- A) Antibióticos vía oral y curaciones ambulatorias
- B) Angiografía
- C) Amputación abierta
- D) Amputación cerrada
- E) Antibióticos endovenosos y debridación quirúrgica

43. [ATENCIÓN PRIMARIA: Condilomas · 4.01.1.058] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Condilomas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

44. [ATENCIÓN PRIMARIA: Onicocriptosis · 4.01.1.059] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Onicocriptosis. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

45. Una paciente de 35 años, con antecedente de bypass gástrico hace un año, presenta crisis de mareos, palpitaciones, malestar general y diarrea, que aparecen después de comer. El diagnóstico más probable es:

- A) Hipoglicemias reactivas
- B) Síndrome de dumping
- C) Hernia del espacio de Petersen
- D) Estenosis de la anastomosis
- E) Déficit de vitamina B12

46. [URGENCIA: Abdomen agudo · 4.01.2.002] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Abdomen agudo. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

47. Niña de 7 años de edad, quien consulta por cuadro de 12 horas de evolución, caracterizada por fiebre y dolor hipogástrico. Al examen físico tiene temperatura: 38,7 grados, FC: 100x', PA: 100/60, dolor a la palpación de hipogastrio, con signo de Blumberg positivo y resistencia en la pared abdominal. Exámenes de laboratorio: 18.000 glóbulos blancos. Sedimento urinario muestra 20 leucocitos por campo. Proteína C reactiva: 15. El diagnóstico más probable es:

- A) Pielonefritis aguda
- B) Apendicitis aguda
- C) ITU baja
- D) Torsión ovárica
- E) Plastrón apendicular

48. Un paciente de 66 años, hipertenso, cardiópata, en tratamiento anticoagulante por una fibrilación auricular crónica, consulta por dolor abdominal brusco, muy intenso, de 6 horas de evolución. Al examen físico presenta ritmo irregular en 2 tiempos y abdomen doloroso a la palpación, con signos peritoneales difusos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Trombosis de la vena mesentérica
- B) Hemoperitoneo
- C) Úlcera péptica perforada
- D) Embolia mesentérica
- E) Aneurisma aórtico abdominal roto

49. Un paciente de 60 años, que hace tres años se habría realizado una colecistectomía con coledocostomía, consulta por cuadro de dolor abdominal tipo cólico intenso, asociado a vómitos alimentarios. No ha podido eliminar gases. Al examen físico presenta dolor difuso a la palpación abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados en intensidad y tonalidad, con blumberg presente. El diagnóstico más probable es:

- A) Obstrucción intestinal
- B) Trombosis venosa mesentérica
- C) Embolia mesenterica
- D) Pancreatitis
- E) Diverticulitis

50. Una paciente de 43 años, multipara, presenta dolor abdominal difuso, intenso y vómitos, con marcado meteorismo. Al examen, tiene FC: 110x', PA: 100/60 mmHg y al examen abdominal se observa cicatriz de cesárea Pfannestiel, y se palpa abdomen muy doloroso tanto a la palpación superficial como profunda, con distensión de la pared abdominal, pérdida de la matidez hepática a la percusión y abolición de los ruidos hidroaéreos a la auscultación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Obstrucción intestinal
- B) Pancreatitis aguda
- C) Perforación intestinal
- D) Megacolon
- E) Embolia mesentérica

51. Un paciente de 28 años tiene un quiste epidérmico en el cuello y consulta porque ahora aumentó de volumen y se ha vuelto doloroso y eritematoso. Al examen físico se lo aprecia según la imagen: FOTO (absceso en el cuello, con algo de eritema alrededor y se ve de aspecto amarillo). La conducta más adecuada es:

- A) Observar evolución
- B) Indicar corticoides tópicos
- C) Indicar antibióticos más drenaje quirúrgico
- D) Realizar resección quirúrgica del quiste
- E) Puncionar la lesión

52. Joven con aumento de volumen blando no adherido en muslo derecho (?era en la espalda), estudio inicial:

- A) Ecografía de piel y partes blandas (REPETIDA DEL 2023)
- B) Psoriasis
- C) Dermatitis atópica
- D) Dermatitis de contacto
- E) Liquen plano

53. Un paciente de 18 años, consulta porque desde hace un año presenta aumento de volumen progresivo en la cara anterior del muslo derecho, que recientemente se ha vuelto dolorosa. Al examen físico se palpa una masa de 10 cm de diámetro, de consistencia dura, no pétreo, sin afectación de la piel. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Realizar resección y biopsia
- B) Observar evolución
- C) Solicitar ecografía de partes blandas
- D) Solicitar radiografía de fémur
- E) Realizar punción y drenaje

54. Un paciente de 52 años, con una gran cicatriz de una quemadura antigua, de gran tamaño, en el muslo derecho, que cicatrizó por segunda intención, refiere que, desde hace dos años, presenta una úlcera en relación a la cicatriz. Al examen físico se observa una úlcera de 2 cm en medio de la cicatriz. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Tratamiento con nitrógeno líquido
- B) Aseo quirúrgico
- C) Resección amplia
- D) Biopsia incisional
- E) Curaciones con povidona y suero fisiológico

BLOQUE 4

POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)

55. Un recién nacido de término, de 5 días de vida, aún no ha eliminado meconio. Además, presenta irritabilidad, vómitos postprandiales frecuentes y distensión abdominal. Al examen tiene ano permeable y se realiza un enema baritado, que muestra colon proximal dilatado y colon distal estrecho. El examen más adecuado para confirmar el diagnóstico es:

- A) TAC abdominal
- B) Colonoscopia
- C) Test del sudor
- D) Biopsia por succión
- E) Cariograma

56. Una paciente de 40 años, IMC: 30, presenta episodios de dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho, desde hace 3 meses, que cede espontáneamente luego de algunos minutos. Se realiza una ecografía, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia): El diagnóstico más probable es:

- A) Colelitiasis
- B) Coledocolitiasis
- C) Colecistitis crónica
- D) Cáncer de vesícula
- E) Colecistitis aguda

57. [ATENCIÓN PRIMARIA: Mesotelioma pleural · 4.01.1.042] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Mesotelioma pleural. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMEch y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroideos sin controles.

58. Diabético fumador con dolor en pantorrillas al caminar 120 metros, ausencia de reflejos patelares, hipoestesia y pulsos pedios débiles. ¿Cuál es el examen de elección?

- A) Electromiografía y velocidad de conducción nerviosa
- B) AngioTAC de extremidades inferiores
- C) Arteriografía de extremidades inferiores
- D) Doppler venoso de extremidades inferiores
- E) Índice tobillo-brazo (ITB)

59. [ATENCIÓN PRIMARIA: Escaras · 4.01.1.052] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Escaras. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroideos sin controles.

60. [URGENCIA: Esofagitis cáustica · 4.01.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Esofagitis cáustica. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

61. [URGENCIA: Prolapso rectal · 4.01.2.009] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Prolapso rectal. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

62. [URGENCIA: Colangitis · 4.01.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Colangitis. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

63. [URGENCIA: Supuración pulmonar · 4.01.2.017] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Supuración pulmonar. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

64. [URGENCIA: Hemoptisis masiva · 4.01.2.018] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Hemoptisis masiva. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

65. [URGENCIA: Pancreatitis aguda · 4.01.2.013] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Pancreatitis aguda. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

66. Un paciente de 28 años sufre una puñalada en el tórax, en el lado derecho. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor torácico y presenta disminución del murmullo pulmonar, asociado a hipersonoridad a la percusión en el hemitórax derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Pedir radiografía de tórax
- B) Pedir resonancia magnética de tórax
- C) Instalar un tubo pleural
- D) Solicitar TAC de tórax
- E) Realizar videotoracoscopia

67. [URGENCIA: Insufic. arterial aguda: embolia, trombosis, traumatismos · 4.01.2.021] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Insufic. arterial aguda: embolia, trombosis, traumatismos. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

68. Un paciente sufre una herida por arma blanca en el abdomen, hace 8 horas. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y examen abdominal sin signos de irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes. Se realiza exploración digital de la herida, con anestesia local, objetivándose laceración del peritoneo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Realizar lavado peritoneal diagnóstico
- B) Realizar ecografía fast
- C) Suturar la herida
- D) Solicitar TAC abdominal
- E) Realizar laparoscopia exploradora

69. [URGENCIA: Traumatismo raquimedular · 4.01.2.020] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Traumatismo raquimedular. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

70. Mujer de 55 años con colecistitis aguda de 48 horas de evolución. Estable hemodinámicamente, fiebre 38°C, leucocitos 14.000. ¿Cuál es el manejo quirúrgico más adecuado?

- A) Colecistectomía laparoscópica precoz (dentro de 72h)
- B) Cirugía electiva en 6 semanas
- C) Drenaje percutáneo y cirugía diferida
- D) Solo ATB EV y observación
- E) Colecistostomía abierta de urgencia

71. Un paciente de 73 años presenta un cuadro de 2 días de dolor abdominal, mayor en la fosa iliaca izquierda. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda, con signos de irritación peritoneal en la zona. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Apendicitis aguda
- B) Cáncer de colon
- C) Obstrucción intestinal
- D) Diverticulitis aguda
- E) Hernia inguinal complicada

72. [URGENCIA: Trauma maxilofacial · 4.01.2.015] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Trauma maxilofacial. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

73. [ATENCIÓN PRIMARIA: Enfermedad diverticular no complicada · 4.01.1.013] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Enfermedad diverticular no complicada. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroideos sin controles.

74. [ATENCIÓN PRIMARIA: Pancreatitis crónica · 4.01.1.029] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Pancreatitis crónica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroideos sin controles.

75. Un paciente de 19 años consulta por dolor torácico derecho, de 24 horas de evolución, que aumenta con la inspiración. Al examen físico, se aprecia disminución del murmullo pulmonar en el lado derecho. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación:

Foto

13

(<https://imgur.com/gallery/U6p0b/comment/113820836>) (La foto fue ennegrecida, para que se pareciera a las del Eunacom real, impreso). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Control radiológico en 24 horas
- B) Solicitar TAC de tórax
- C) Realizar cirugía abierta
- D) Drenaje con tubo pleural
- E) Videotoroscopia

76. Mujer de 45 años con várices en extremidades inferiores bilaterales, sin úlceras ni tromboflebitis. Sin otros antecedentes mórbidos. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

- A) Anticoagulación oral
- B) Flebectomía inmediata
- C) Escleroterapia de urgencia
- D) Medidas conservadoras: dieta, ejercicio y medias compresivas
- E) Derivación vascular urgente

77. [ATENCIÓN PRIMARIA: Cicatrices viciosas · 4.01.1.057] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Cicatrices viciosas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

- A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
- B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
- C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
- D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
- E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroideos sin controles.

78. [URGENCIA: Hemorragia digestiva alta · 4.01.2.004] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Hemorragia digestiva alta. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

79. Paciente de 43 años, con historia de epigastralgia desde hace 3 semanas sin otros síntomas, como parte del estudio de su patología se realiza endoscopia digestiva alta que muestra gastritis erosiva, sin presencia de úlcera péptica activa y con test de ureasa positivo, por este motivo se indica tratamiento erradicador del helicobacter pylori. Tres horas luego del procedimiento, evoluciona con dolor torácico irradiado a hombro derecho y sensación febril. El examen de elección para confirmar el diagnóstico en este caso es:

- A) Radiografía de tórax
- B) Repetir endoscopia
- C) Tomografía axial computada de tórax
- D) Radiografía baritada de esófago-estómago-duodeno
- E) Electrocardiograma

80. [URGENCIA: Traumatismos vasculares · 4.01.2.023] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Traumatismos vasculares. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

81. [URGENCIA: Septicemia · 4.01.2.029] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Septicemia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

82. [URGENCIA: Shock · 4.01.2.031] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Shock. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

83. [URGENCIA: Paro cardiorespiratorio · 4.01.2.030] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Paro cardiorespiratorio. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

84. Niño con quemadura en palmas y dedos, eritema importante y ampollas, inquieto e irritable en urgencias. ¿Cuál es la conducta inicial?

- A) Aplicar apósitos de plata y hospitalizar
- B) Enfriar con agua fría y cubrir con gasa estéril
- C) Indicar analgesia endovenosa
- D) Hospitalizar para manejo de quemaduras
- E) Debridación bajo anestesia general inmediata

85. Una mujer de 28 años, trabajadora del área de la salud, es encontrada inconsciente por su pareja en el baño de su casa. Al examen físico, está comprometida de conciencia, tiene frecuencia cardíaca de 60 por minuto, frecuencia respiratoria de 8 por minuto y se observan pupilas mióticas, sin focalidad neurológica. ¿Qué tipo de fármaco es el responsable del cuadro de intoxicación de esta paciente?

- A) Benzodiacepinas
- B) Barbitúricos
- C) Antidepresivos tricíclicos
- D) Opioides
- E) Hipoglicemiantes

86. Un paciente, apendicetomizado hace 6 horas evoluciona con malestar general y dolor abdominal. Su pulso es regular a 120 latidos por minuto y su presión arterial es 90/50 mmHg. En el examen abdominal presenta dolor y signos peritoneales en el hemiabdomen inferior. El diagnóstico más probable es:

- A) Hemoperitoneo
- B) Evisceración
- C) Trombosis de la vena porta
- D) Dehiscencia de la base apendicular
- E) Tromboembolismo pulmonar masivo

87. Un niño de 6 años sufre un accidente en el campo, golpeándose con un palo en la cabeza y resultando con una herida supraciliar derecha de 5 cm de longitud. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Afrontamiento con cianoacrilato
- B) Afrontamiento con tela adhesiva
- C) Sutura con punto separado
- D) Sutura intradérmica
- E) Dejar que cure por segunda intención

88. [URGENCIA: Heridas y contusiones menores · 4.01.2.025] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Heridas y contusiones menores. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

89. Un paciente de 77 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, consulta por dolor abdominal de tipo inespecífico, de 2 meses de evolución, sin otros síntomas. En su examen físico se palpa un tumor abdominal de 4 a 5 cm de diámetro, en la zona umbilical, pulsátil, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Trombosis mesentérica
- B) Tumor de colon
- C) Tumor de páncreas
- D) Disección aórtica
- E) Aneurisma aórtico abdominal

90. [URGENCIA: Trauma · 4.01.2.027] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Trauma. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

- A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
- B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
- C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
- D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
- E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 Respuesta: A Divertículos esofágicos

4.01.1.002

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Divertículos esofágicos" (4.01.1.002), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 2 Respuesta: A Pólipos de colon y recto

4.01.1.014

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Pólipos de colon y recto" (4.01.1.014), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 3 Respuesta: A Hidatidosis pulmonar

4.01.1.037

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hidatidosis pulmonar" (4.01.1.037), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 4 Respuesta: A

4.01.1.044

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea" (4.01.1.044), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 5 Respuesta: A Enfermedad renovascular

4.01.1.045

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Enfermedad renovascular" (4.01.1.045), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 6 Respuesta: C

4.01.1.049

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Trombosis venosa profunda y tromboflebitis

Por ser postQx es TEP y por el compromiso HDN es masivo problemamente

PREGUNTA 7 Respuesta: A

4.01.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Colecistitis crónica" (4.01.1.025), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 8 Respuesta: A

4.01.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer del esófago" (4.01.1.005), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 9 Respuesta: E

4.01.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar **GES**

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

La derivación gastroyeyunal es menos agresiva que la hgastrectomía y permite reestablecer el tránsito gastrointestinal.

PREGUNTA 10 Respuesta: A

4.01.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer colorectal" (4.01.1.015), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 11 Respuesta: D

4.01.1.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar **GES**

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

Es un cáncer de recto, que aumenta el riesgo en el paciente VIH, en especial con VPH de alto riesgo (serotipos 16 y 18).

PREGUNTA 12 Respuesta: E

4.01.1.028 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar **GES**

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

Lo correcto es hacer una cirugía abierta, con cuña hepática y linfadenectomía y no una colecistectomía radical, ya que la vesícula ya se extirpó. Sin embargo, de las alternativas que había, era la más aceptable.

PREGUNTA 13 Respuesta: A

4.01.1.030 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer de páncreas y otros tumores preampulares" (4.01.1.030), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 14 **Respuesta: A**

4.01.1.031

Dx: Sospecha · Tx: Inicial ·
Seg: Derivar**Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer de páncreas" (4.01.1.031), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 15 **Respuesta: A**

4.01.1.033

Dx: Específico · Tx: Inicial ·
Seg: Derivar**Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer del tiroides" (4.01.1.033), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 16 **Respuesta: B**

4.01.1.035

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg: Derivar

GES

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

El cáncer de mama es el que da metástasis ganglionares a la axila con mayor frecuencia. Que sea indolora descarta hidrosadenitis. Lipoma es blando. TBC ganglionar es rara y suele tener una clínica más inflamatoria, con fistulización: sale caseum.

PREGUNTA 17 **Respuesta: A**

4.01.1.039

Dx: Sospecha · Tx: Inicial ·
Seg: Derivar**Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cáncer pulmonar" (4.01.1.039), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 18 **Respuesta: A**

4.01.1.040

Dx: Sospecha · Tx: Inicial
· Seg: Derivar**Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hernias diafragmáticas traumáticas y congénitas" (4.01.1.040), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

BLOQUE 2**ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO · SOLUCIONARIO OFICIAL****PREGUNTA 19** **Respuesta: A** **Divertículo de Meckel**

4.01.1.003

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Divertículo de Meckel" (4.01.1.003), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 20 **Respuesta: A** **Hidatidosis hepática**

4.01.1.022

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hidatidosis hepática" (4.01.1.022), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 21 Respuesta: A Nódulo pulmonar solitario

4.01.1.038

Dx: Sospecha • Tx: Inicial • Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Nódulo pulmonar solitario" (4.01.1.038), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 22 Respuesta: A

4.01.1.006

Dx: Sospecha • Tx: Inicial
• Seg: Derivar**Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hernia hiatal" (4.01.1.006), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 23 Respuesta: D

4.01.1.021

Dx: Sospecha • Tx:
Inicial • Seg: Completo

GES

Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones

Es una hernia femoral clásica (bajo el ligamento inguinal). Es más frecuente en mujeres.

PREGUNTA 24 Respuesta: A

4.01.1.001

Dx: Sospecha • Tx:
Inicial • Seg: Derivar**Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Patología glándulas salivales" (4.01.1.001), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 25 Respuesta: A

4.01.1.011

Dx: Sospecha • Tx:
Inicial • Seg: Derivar**Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas**

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Fístulas del intestino delgado" (4.01.1.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 26 Respuesta: B

4.01.1.016

Dx: Específico • Tx:
Inicial • Seg:
Completo

GES

Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

Hemorroides externas trombosadas en primeras 72h: trombectomía bajo anestesia local alivia el dolor en forma inmediata. Después de 72h, el manejo es conservador pues el trombo se reabsorbe.

PREGUNTA 27 Respuesta: B

4.01.1.017

Dx: Específico • Tx:
Inicial • Seg: Derivar

GES

Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

Probable absceso perianal. Debe ser drenado en pabellón.

PREGUNTA 28**Respuesta: C****Patología Orifical Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas**

4.01.1.020

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg:
Completo

GES

Fisura anal clásica.

PREGUNTA 29**Respuesta: A****Patología Orifical Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas**

4.01.1.023

Dx: Sospecha · Tx:
Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Quistes y abscesos hepáticos" (4.01.1.023), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 30**Respuesta: A****Patología Orifical Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas**

4.01.1.034

Dx: Sospecha · Tx:
Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Patología benigna del tiroides" (4.01.1.034), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 31**Respuesta: C****Patología Orifical Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas**

4.01.1.036

Dx: Sospecha · Tx:
Inicial · Seg:
Completo

GES

Es un fibroadenoma clásico. Se sigue con ecografía cada 6 meses por 2 años. Se ve sólido, hipocogénico, con bordes bien definidos, habitualmente con forma oval y orientación horizontal. Suele no tener sombra ni refuerzo posterior.

PREGUNTA 32**Respuesta: A****Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas**

4.01.1.007

Dx: Sospecha · Tx: Inicial ·
Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tumores gástricos benignos" (4.01.1.007), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 33**Respuesta: A****Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas**

4.01.1.009

Dx: Sospecha · Tx: Inicial ·
Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tumores del intestino delgado" (4.01.1.009), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 34**Respuesta: C****Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas**

4.01.1.018

Dx: Sospecha · Tx: Inicial
· Seg: Completo

GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 43). Evalúa el manejo clínico de Enfermedades del seno pilonidal según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 35 Respuesta: A

4.01.1.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tumores hepáticos" (4.01.1.024), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 36 Respuesta: B

4.01.1.032 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

Es un quiste branquial clásico (zona lateral del cuello y crecimiento muy lento). No puede ser nódulo tiroideo, por la ubicación (la tiroides está en la zona media inferior del cuello). Tampoco un quiste del conducto tirogloso, porque este es de la línea media. La adenopatía tuberculosa o escrófula crece más rápido y suele fistulizarse, dando salida a material caseoso.

BLOQUE 3

POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS) · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 Respuesta: A Acalasia

4.01.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Acalasia" (4.01.1.004), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 38 Respuesta: B Ictericia obstructiva

4.01.1.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 161). Evalúa el manejo clínico de Ictericia obstructiva según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 39 Respuesta: A Síndromes mediastínicos

4.01.1.041 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndromes mediastínicos" (4.01.1.041), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 40 Respuesta: A Insuficiencia cerebro vascular

4.01.1.046 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Insuficiencia cerebro vascular" (4.01.1.046), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 41 Respuesta: C

4.01.1.050 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Úlceras de las piernas (venosas, varicosas, hipert. y específicas)

Úlcera venosa: Las úlceras venosas suelen ser poco dolorosas o incluso indoloras. Se ubican generalmente en el maléolo interno y se asocian al síndrome postflebítico, que se caracteriza por hiperpigmentación de la piel. En contraste, las úlceras arteriales son dolorosas y se ubican con mayor frecuencia en el maléolo externo, los ортеjos o los talones. El fondo de las úlceras arteriales es isquémico, de color pálido o blanco, mientras que el fondo de las úlceras venosas es hiperémico y violáceo.

PREGUNTA 42 **Respuesta: E** **Pie diabético**

4.01.1.051

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una fasciitis necrotizante, sin compromiso óseo (no amputar). Si tuviera la osteomielitis, se amputa el pie diabético.

PREGUNTA 43 **Respuesta: A** **Condilomas**

4.01.1.058

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Condilomas" (4.01.1.058), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 44 **Respuesta: A** **Onicocriptosis**

4.01.1.059

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Onicocriptosis" (4.01.1.059), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 45 **Respuesta: B** **Obesidad mórbida**

4.01.1.060

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene un síndrome de dumping clásico (aprender dicha clínica), frecuente complicación de un by-pass gástrico. Se caracteriza por síntomas disautonómicos, que pueden ser muy similares a una hipoglucemia, por lo que siempre se debe solicitar HGT para descartarla. Sin embargo, la diarrea no calza con hipoglucemia, sino solo con dumping.

PREGUNTA 46 **Respuesta: A**

4.01.2.002

Dx: Específico · Tx: Inicial
· Seg: Derivar**Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Abdomen agudo" como urgencia clínica (4.01.2.002), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 47 **Respuesta: B**

4.01.2.006

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg: Derivar

GES

Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía

Es una apendicitis clásica.

PREGUNTA 48 **Respuesta: D**

4.01.2.007

Dx: Sospecha · Tx:
Inicial · Seg: Derivar

GES

Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía

Es una embolia mesentérica clásica, por la FA. Sin embargo, suele cursar sin signos peritoneales al inicio, pero había pasado ya mucho tiempo, por lo que sí aparecen dichos signos.

PREGUNTA 49 **Respuesta: A**

4.01.2.005

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg: Derivar

GES

Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

Es una obstrucción intestinal clásica, probablemente por bridas (antecedente de cirugía).

PREGUNTA 50

Respuesta: C

4.01.2.003

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)

La pérdida de la matidez hepática sugiere un neumoperitoneo, secundario a una perforación. También tiene clínica de la peritonitis secundaria: abolición de RHA, dolor intenso.

PREGUNTA 51

Respuesta: C

4.01.1.055

Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

GES

Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fistulas

Tiene un quiste epidérmico abscedado, lo que se trata con antibióticos (antiestafilocócicos: ej. cloxacilina) más drenaje quirúrgico. Eventualmente, el quiste sí se debe resecar, pero no mientras está infectado.

PREGUNTA 52

Respuesta: A

4.01.1.053

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 79). Evalúa el manejo clínico de Tumores benignos de partes blandas según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 53

Respuesta: C

4.01.1.054

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

Es un probable sarcoma de partes blandas. Debe estudiarse con resonancia magnética nuclear, como examen de elección, para determinar el grado de invasión, antes de definir qué tipo de cirugía se le hará. Como no aparecía en las opciones, lo más razonable es hacer la ecografía, porque al menos es suficiente para distinguir entre un tumor benigno y uno maligno. Luego sí se hará la resección y biopsia.

PREGUNTA 54

Respuesta: D

4.01.1.056

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

GES

Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

Tiene una úlcera de Majorlin, que es un tipo de carcinoma espinocelular de muy lento crecimiento, que aparece en cicatrices de grandes quemaduras. Su diagnóstico es la biopsia incisional o con una biopsia "punch" y luego de confirmar la histología, se procede a la excisión completa y manejo oncológico. En ocasiones, el carcinoma solo está en una zona del borde de la úlcera, por lo que se recomienda varias biopsias incisionales. Si no lo sabían, pues ahora ya lo saben y sea como sea, tenía "pinta" de cáncer, así que a biopsiarlo.

BLOQUE 4

POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS) · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55

Respuesta: D

Megacolon

4.01.1.012

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Se sospecha una enfermedad de Hirschsprüng, que se diagnostica con la biopsia intestinal, que muestra aganglionosis del plexo submucoso o mientérico, en el segmento afectado.

PREGUNTA 56

Respuesta: A

Litiasis biliar

4.01.1.027

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una imagen de cálculos con la sombra acústica clásica. Se debe programar cirugía electiva.

PREGUNTA 57

Respuesta: A

Mesotelioma pleural

4.01.1.042

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Mesotelioma pleural" (4.01.1.042), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 58 **Respuesta: E** **Insuficiencia arterial crónica** 4.01.1.047 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Índice tobillo-brazo (ITB)

PREGUNTA 59 **Respuesta: A** **Escaras** 4.01.1.052 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Escaras" (4.01.1.052), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 60 **Respuesta: A** **Esofagitis cáustica** 4.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Esofagitis cáustica" como urgencia clínica (4.01.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 61 **Respuesta: A** **Prolapso rectal** 4.01.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Prolapso rectal" como urgencia clínica (4.01.2.009), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 62 **Respuesta: A** **Colangitis** 4.01.2.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Colangitis" como urgencia clínica (4.01.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 63 **Respuesta: A** **Supuración pulmonar** 4.01.2.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Supuración pulmonar" como urgencia clínica (4.01.2.017), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 64 **Respuesta: A** **Hemoptisis masiva** 4.01.2.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Hemoptisis masiva" como urgencia clínica (4.01.2.018), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 65 **Respuesta: A** **Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía** 4.01.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Pancreatitis aguda" como urgencia clínica (4.01.2.013), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 66**Respuesta: A**

4.01.2.016

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg: Derivar**GES****Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante**

Tiene una probable herida penetrante de tórax, con un neumotórax traumático. No tiene clínica de neumotórax a tensión, así que no hay que puncionar el segundo espacio intercostal. Lo primero siempre es pedir la radiografía de tórax, tanto para ver el grado del neumotórax, como para descartar otras complicaciones (ej: hemotórax).

PREGUNTA 67**Respuesta: A**

4.01.2.021

Dx: Sospecha · Tx: Inicial ·
Seg: Derivar**Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Insufic. arterial aguda: embolia, trombosis, traumatismos" como urgencia clínica (4.01.2.021), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 68**Respuesta: E**

4.01.2.010

Dx: Sospecha · Tx:
Inicial · Seg: Derivar**GES****Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia**

Tiene una herida penetrante abdominal (ladera el peritoneo). La mayoría de los autores recomienda explorar, idealmente por laparoscopia. De todos modos algunos recomiendan hacer EcoFast si está en tan buenas condiciones y tiene buena evolución (como es este caso). No es un tema cerrado, sino controvertido.

PREGUNTA 69**Respuesta: A**

4.01.2.020

Dx: Sospecha · Tx: Inicial ·
Seg: Derivar**Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Traumatismo raquimedular" como urgencia clínica (4.01.2.020), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 70**Respuesta: A**

4.01.2.011

Dx: Específico · Tx:
Inicial · Seg: Derivar**GES****Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap**

Colecistitis aguda no complicada: colecistectomía laparoscópica precoz (<72h del diagnóstico) es superior al manejo diferido. Menor complicaciones, estadía hospitalaria y conversión a cirugía abierta.

PREGUNTA 71**Respuesta: D**

4.01.2.008

Dx: Sospecha · Tx:
Inicial · Seg: Derivar**GES****Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx**

Cuadro clásico

PREGUNTA 72**Respuesta: A**

4.01.2.015

Dx: Sospecha · Tx: Inicial ·
Seg: Derivar**Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Trauma maxilofacial" como urgencia clínica (4.01.2.015), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 73 Respuesta: A

4.01.1.013

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo

Enfermedad diverticular no complicada

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Enfermedad diverticular no complicada" (4.01.1.013), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 74 Respuesta: A Pancreatitis crónica

4.01.1.029

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Pancreatitis crónica" (4.01.1.029), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 75 Respuesta: D Síndrome de ocupación pleural

4.01.1.043

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Por la clínica era un neumotórax. La radiografía era muy oscura, pero con imaginación y paciencia, se veía el neumotórax derecho (acá se ve más que en el real). Por ser mayor a 15%, se trata con tubo pleural.

PREGUNTA 76 Respuesta: D

4.01.1.048

Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo

Várices. Insuficiencia venosa crónica

Varices simples sin complicaciones: manejo inicial conservador con elevación de extremidades, ejercicio (caminata), control de peso y medias de compresión elástica. La cirugía/escleroterapia se reserva para cuando las medidas conservadoras fallan o hay complicaciones.

PREGUNTA 77 Respuesta: A Cicatrices viciosas

4.01.1.057

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Cicatrices viciosas" (4.01.1.057), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 78 Respuesta: A Hemorragia digestiva alta

4.01.2.004

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Hemorragia digestiva alta" como urgencia clínica (4.01.2.004), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 79 Respuesta: C Perforación esofágica - Mediastinitis

4.01.2.019

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Sospecha de perforación esofágica iatrogénica, con mediastinitis secundaria. El TAC es el mejor examen.

PREGUNTA 80 Respuesta: A Traumatismos vasculares

4.01.2.023

Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Traumatismos vasculares" como urgencia clínica (4.01.2.023), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 81 Respuesta: A Septicemia

4.01.2.029

Dx: Sospecha • Tx: Inicial • Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Septicemia" como urgencia clínica (4.01.2.029), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 82 Respuesta: A Shock

4.01.2.031

Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Shock" como urgencia clínica (4.01.2.031), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 83 Respuesta: A

4.01.2.030

Dx: Específico • Tx: Completo
• Seg: Derivar**Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia**

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Paro cardiorespiratorio" como urgencia clínica (4.01.2.030), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 84 Respuesta: C

4.01.2.026

Dx: Específico • Tx:
Inicial • Seg: Derivar

GES

Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

Indicar analgesia endovenosa

PREGUNTA 85 Respuesta: D

4.01.2.028

Dx: Específico • Tx:
Inicial • Seg: Derivar

GES

Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales

Síndrome Opiode: Este síndrome se caracteriza por compromiso de la conciencia, depresión respiratoria y miosis puntiforme (pupilas contraídas). Es importante diferenciarlo de otros síndromes: el síndrome por benzodiazepinas también presenta compromiso de conciencia y depresión respiratoria, pero sin alteración pupilar significativa; los síndromes adrenérgico y anticolinérgico causan midriasis (pupilas dilatadas); y el síndrome colinérgico, al igual que el opioide, se caracteriza por miosis (pupilas contraídas).

PREGUNTA 86 Respuesta: A

4.01.2.024

Dx: Específico • Tx:
Inicial • Seg: Derivar

GES

Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)

[Pregunta disputada] Es una pregunta difícil, ya que el compromiso hemodinámico y los signos peritoneales pueden corresponder tanto a un hemoperitoneo, como a la dehiscencia de la base apendicular. Sin embargo, por predominar el compromiso hemodinámico, nos inclinamos a marcar hemoperitoneo. Si, en cambio, hubiese tenido predominancia de los signos peritoneales, nos habríamos inclinado a la dehiscencia.

PREGUNTA 87 Respuesta: D

4.01.2.014

Dx: Específico • Tx:
Inicial • Seg: Derivar

GES

Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

Si bien también se puede afrontar con punto separado, en pediatría y también en adultos, se prefiere la sutura intradérmica para las heridas grandes de la cara, por su mejor resultado estético.

PREGUNTA 88 **Respuesta: A**

4.01.2.025

Dx: Específico • Tx:
Completo • Seg: Completo

Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Heridas y contusiones menores" como urgencia clínica (4.01.2.025), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 89 **Respuesta: E**

4.01.2.022

Dx: Específico • Tx:
Inicial • Seg: Derivar

GES

Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones

Un tumor pulsátil en esa zona, hace pensar en un AAA.

PREGUNTA 90 **Respuesta: A**

4.01.2.027

Dx: Sospecha • Tx: Inicial •
Seg: Derivar

Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Trauma" como urgencia clínica (4.01.2.027), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.